SHZ237 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET

DR. YUNUS SERHAT ÇAYIR

FİZİKSEL ENGELLİLİK VE SOSYAL HİZMET

Soru: Engel Bedende mi, Çevrede mi?

- Omurilik yaralanması sonrası tekerlekli sandalye kullanan bir genç, iş görüşmesine çağrılıyor; ancak şirket asansörsüz bir binanın üçüncü katında.
- Aynı kişi, erişilebilir bir binada ve uyarlanmış bir iş ortamında görevini sorunsuz biçimde yerine getirebiliyor.
- Bu durumda kişinin istihdama katılımını sınırlayan şey yürüyememesi mi, yoksa binanın tasarımı mı?
- Temel soru: Fiziksel engellilikte sosyal hizmet uzmanı neyi değerlendirmeli, neyi değiştirmeye çalışmalıdır?

Dersin Amacı ve Akışı

- Fiziksel engelliliğin tanımını, başlıca türlerini ve nedenlerini tartışmak.
- Fiziksel engelliliği ICF çerçevesinde birey ve çevre etkileşimi olarak ele almak.
- Türkiye'deki verileri, değerlendirme sistemini ve temel hizmetleri incelemek.
- Bireyin ve ailenin yaşadığı psikososyal, ekonomik ve çevresel güçlükleri değerlendirmek.
- Mikro, mezzo ve makro düzeyde sosyal hizmet müdahalesini bir vaka üzerinden tartışmak.

Fiziksel Engellilik Nedir?

- Fiziksel engellilik; hareket, denge, koordinasyon, kas gücü, dayanıklılık veya el becerilerini etkileyen uzun süreli yetersizliklerle ilişkilidir.
- Yetersizlik kas-iskelet sistemi, sinir sistemi veya kronik bir hastalık kaynaklı olabilir.
- Fiziksel engellilik tek tip bir deneyim değildir; görünür veya görünmez, durağan veya ilerleyici olabilir.
- Sosyal hizmet açısından asıl soru tanı değil, yetersizliğin çevresel ve toplumsal koşullarla etkileşerek katılımı nasıl sınırladığıdır.

Fiziksel Engelliliğin Başlıca Türleri

- Ortopedik yetersizlikler: uzuv kaybı (amputasyon), kas-iskelet sistemi deformiteleri, kemik ve eklem hastalıkları.
- Nörolojik kökenli yetersizlikler: omurilik yaralanması, serebral palsi, inme, spina bifida, travmatik beyin hasarı.
- Nöromüsküler ve ilerleyici durumlar: kas hastalıkları (ör. Duchenne musküler distrofisi), spinal müsküler atrofi, multipl skleroz.
- Kronik hastalıklara bağlı işlev kayıpları: romatizmal hastalıklar, ileri kalp ve akciğer hastalıkları, diyabete bağlı komplikasyonlar.
- Sınıflandırmalar hizmet planlamasında yol gösterir; ancak aynı tanıyı alan kişilerin deneyimleri birbirinden çok farklı olabilir.

Omurilik Yaralanmaları

- Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, iş kazası, spor yaralanması veya şiddet sonucu ortaya çıkar; genç erkeklerde daha sık görülür.
- Parapleji alt ekstremiteleri ve gövdenin bir bölümünü; tetrapleji (kuadripleji) dört ekstremiteyi etkiler.
- Hareket kaybının yanı sıra duyu kaybı, mesane-bağırsak kontrolü, spastisite, ağrı ve bası yarası riski gibi ikincil sorunlar gelişebilir.
- Ani başlangıç; kişinin ve ailenin yaşamında çalışma, barınma, ilişkiler ve gelir alanlarında hızlı bir yeniden yapılanma gerektirir.
- Sosyal hizmet uzmanı akut dönemden itibaren ekipte yer alarak taburculuk ve topluma dönüş sürecini planlar.

Serebral Palsi

- Gelişmekte olan beyinde doğum öncesi, doğum sırasında veya erken çocuklukta oluşan, ilerleyici olmayan hasara bağlı hareket ve postür bozukluğudur.
- Çocukluk döneminde fiziksel engelliliğin en sık nedenleri arasında yer alır.
- Etkilenme düzeyi çok farklıdır: bağımsız yürüyebilen çocuklardan yoğun destek gerektirenlere kadar geniş bir yelpaze vardır.
- Konuşma, yutma, görme veya öğrenme güçlükleri eşlik edebilir; ancak serebral palsi zihinsel yetersizlikle eş anlamlı değildir.
- Aileyle çalışmada özel eğitim, rehabilitasyon, yardımcı teknoloji ve yaşam boyu geçiş dönemleri birlikte planlanmalıdır.

İlerleyici Durumlar ve Kas Hastalıkları

- Duchenne musküler distrofisi, spinal müsküler atrofi ve multiple skleroz gibi durumlarda işlevsellik zaman içinde değişebilir.
- Multiple skleroz genellikle genç yetişkinlikte başlar; ataklarla seyredebilir ve yorgunluk gibi görünmeyen belirtiler içerebilir.
- İlerleyici durumlarda kişi ve aile, her yeni işlev kaybında yeniden uyum sağlamak zorunda kalabilir.
- Hizmet planı yalnızca bugünkü ihtiyaca değil, öngörülebilir değişikliklere göre de esnek biçimde hazırlanmalıdır.
- Gelecek planlaması (bakım, barınma, çalışma, karar desteği) kişinin tercihleri merkeze alınarak erken dönemde konuşulmalıdır.

Doğuştan ve Sonradan Edinilmiş Engellilik

- Doğuştan veya erken çocuklukta ortaya çıkan engellilikte kişi, engelliliği büyüme süreci içinde kimliğinin bir parçası olarak deneyimleyebilir.
- Sonradan edinilmiş engellilikte (kaza, hastalık, afet) önceki yaşam düzeni, roller ve beden algısı aniden değişir.
- Sonradan edinilmiş engellilikte kayıp ve yas tepkileri, meslek ve rol kaybı daha belirgin olabilir.
- Doğuştan engellilikte ise aile süreçleri, eğitim yaşamı ve yetişkinliğe geçiş daha fazla öne çıkabilir.
- Her iki durumda da genelleme yapılmamalı; kişinin kendi anlatısı değerlendirmenin merkezinde olmalıdır.

Fiziksel Engelliliğin Nedenleri ve Önleme

- Doğum öncesi ve doğum sırasında etkenler: genetik durumlar, gebelikte enfeksiyonlar, erken doğum ve doğum komplikasyonları.
- Kazalar: trafik kazaları, iş kazaları, ev içi düşmeler ve spor yaralanmaları.
- Kronik hastalıklar: inme, diyabet ve damar hastalıklarına bağlı uzuv kayıpları, romatizmal hastalıklar.
- Afetler ve silahlı çatışmalar: 6 Şubat 2023 depremleri sonrası uzuv kaybı ve omurilik yaralanması yaşayan kişiler bu riski görünür kılmıştır.
- Önleme politikaları önemlidir; ancak önleme söylemi, engelli bireyleri “önlenmesi gereken bir sorun” olarak konumlandırmamalıdır.

ICF Çerçevesinde Fiziksel Engellilik

- DSÖ’nün İşlevsellik, Engellilik ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF, 2001) biyopsikososyal bir bakış sunar.
- Vücut işlevleri ve yapıları: kas gücü, eklem hareketi, duyu, uzuv varlığı.
- Etkinlik: yürüme, giyinme, nesne taşıma gibi bireysel görevleri yerine getirme.
- Katılım: eğitim, iş, aile ve toplum yaşamında yer alma.
- Çevresel etkenler (bina, ulaşım, tutumlar, hizmetler, mevzuat) ve kişisel etkenler (yaş, cinsiyet, baş etme biçimleri) bu alanları birlikte etkiler.

Aynı Tanı, Farklı Yaşamlar: ICF Örneği

- İki kişi aynı düzeyde omurilik yaralanması yaşamış ve tekerlekli sandalye kullanıyor olsun.
- Birinci kişi: asansörlü bir binada yaşıyor, erişilebilir toplu taşımaya, uyarlanmış bir işyerine ve destekleyici bir aileye sahip.
- İkinci kişi: kırsal bir yerleşimde, merdivenli bir evde yaşıyor; düzenli ulaşım ve gelir olanağı yok, rehabilitasyon merkezine uzak.
- Vücut işlevleri benzer olsa da katılım düzeyleri ve yaşam kaliteleri çok farklıdır.
- Sosyal hizmet müdahalesinin hedefi, bu farkı yaratan çevresel ve yapısal etkenlerdir.

Türkiye’de Fiziksel Engelliliğe İlişkin Veriler

- 2011 Nüfus ve Konut Araştırması’na göre 3 ve üzeri yaştaki nüfusun %6,9’u (yaklaşık 4,9 milyon kişi) en az bir alanda engellilik yaşamaktadır.
- Yürümede ya da merdiven inip çıkmada zorluk yaşayanların oranı %3,3 (yaklaşık 2,3 milyon kişi); bir şeyler taşıma veya tutmada zorluk yaşayanların oranı %4,1’dir.
- Hareketle ilgili zorluklar, engel grupları arasında en yüksek oranlara sahiptir ve kadınlarda daha yüksektir.
- Araştırma, tıbbi tanıdan çok işlevsel sınırlılıkları ölçen Washington Grubu soru setine dayanmaktadır.
- Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı EYHGM İstatistik Bülteni (Ekim 2023).

Ulusal Engelli Veri Sistemi ve Verilerin Sınırlılıkları

- Engelli sağlık kurulu raporlarına dayanan idari kayıt sisteminde yaklaşık 2,5 milyon kişi kayıtlıdır.
- Kayıtlı kişilerin %13,8'i ortopedik engel grubunda, %40,6'sı süreğen hastalık grubundadır.
- Bu sistem rapor almamış ve devletle hizmet teması kurmamış kişileri kapsamaz.
- Araştırma verileri ile idari kayıtlar farklı tanımlara dayandığı için doğrudan karşılaştırılmamalıdır.
- Güncel ve ayrıntılı engellilik verisinin eksikliği, hizmet planlaması ve politika geliştirme açısından önemli bir sorundur.

Engellilik Değerlendirmesi ve Sağlık Kurulu Raporu

- Yetişkinlerde engellilik oranı, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'e göre yetkili hastanelerce belirlenir.
- 18 yaş altındaki çocuklar için Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) düzenlenir.
- Rapordaki oran ve ibareler; aylık, evde bakım, istihdam, vergi indirimi ve diğer haklara erişimde belirleyici olur.
- Rapor süreçleri karmaşık, zaman alıcı ve erişilmesi güç olabilir; bu durum kendi başına bir erişim engeline dönüşebilir.
- Sosyal hizmet uzmanı kişiyi süreç hakkında bilgilendirir, gerekli yönlendirmeyi yapar ve itiraz yollarını kişiyle birlikte değerlendirir.

Fiziksel Erişilebilirlik ve Yapılı Çevre

- 5378 sayılı Kanun, kamuya açık binalar, açık alanlar ve toplu taşımanın erişilebilir hâle getirilmesini düzenler.
- Kanunda öngörülen süreler dolmuş olmasına karşın uygulamada önemli eksiklikler sürmektedir.
- İllerde valilikler bünyesindeki Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları denetim yapar; 2022'de 5.278 denetim gerçekleştirilmiştir.
- Rampa eğimi, kaldırım yüksekliği, asansör, tuvalet ve otopark düzenlemeleri günlük yaşamı doğrudan belirler.
- Erişilemeyen çevre, kişinin eğitim, iş, sağlık ve sosyal yaşama katılımını zincirleme biçimde kısıtlar.

Erişilebilirliğin Boyutları

- Fiziksel erişilebilirlik: konut, kamu binaları, kaldırımlar, parklar ve sağlık kuruluşları.
- Ulaşım: alçak tabanlı araçlar, durak düzenlemeleri, şehirlerarası ulaşım ve kırsal bölgelerde ulaşım olanakları.
- Bilgi ve iletişim: başvuru süreçleri, dijital hizmetler ve bilgilendirme materyalleri.
- Tutumsal erişilebilirlik: acıma, aşırı koruma, yok sayma ve “yapamaz” varsayımı katılımı fiziksel engeller kadar sınırlayabilir.
- Ekonomik erişilebilirlik: yardımcı teknoloji, ev uyarlaması ve ulaşım maliyetleri hizmetlere erişimi belirler.

Yardımcı Teknolojiler ve Ev Uyarlamaları

- Tekerlekli sandalye, yürüteç, protez, ortez, transfer araçları ve hasta yatağı gibi araçlar bağımsızlığı artırır.
- Ev uyarlamaları: kapı genişletme, banyo düzenlemesi, tutunma barları, rampa veya asansör.
- Araç, kişiye uygun ölçülmeli ve seçilmeli; kullanım eğitimi, bakım ve onarım süreçleri de planlanmalıdır.
- Uygun olmayan araç; bası yarası, yaralanma ve aracın kullanılmaması gibi sonuçlara yol açabilir.
- Sosyal hizmet uzmanı maliyet, temin ve geri ödeme süreçlerinde kişiyi ve aileyi destekler; fizyoterapist ve ergoterapistle iş birliği yapar.

Psikososyal Uyum Süreci

- Sonradan edinilmiş fiziksel engellilik; şok, kayıp, yas, öfke, kaygı ve belirsizlik duygularını beraberinde getirebilir.
- Uyum doğrusal ya da evrensel aşamalarla ilerlemez; kişiler farklı zamanlarda farklı tepkiler verebilir.
- Kişinin anlam dünyası, baş etme biçimleri, sosyal desteği ve ekonomik güvencesi uyum sürecini belirler.
- “Kabullenmeme” olarak etiketlenen tepkiler, bazen erişilemeyen çevreye ve yetersiz hizmetlere verilen anlaşılır tepkilerdir.
- Sosyal hizmet uzmanı umudu, güçlü yönleri ve kişinin kendi hedeflerini merkeze alan bir destek ilişkisi kurar.

Ruh Sağlığı, Beden İmajı ve Sosyal İlişkiler

- Fiziksel engelli bireylerde depresyon ve kaygı riski, özellikle ani başlangıçlı durumlarda artabilir.
- Bu risk büyük ölçüde ağrı, sosyal izolasyon, işsizlik ve ayrımcılık gibi koşullarla ilişkilidir.
- Beden imajı, mahremiyet, cinsellik ve partner ilişkileri sıklıkla göz ardı edilen ancak önemli yaşam alanlarıdır.
- Arkadaşlık ve toplumsal ilişkiler, erişilebilir mekânlar ve ulaşım olmadan sürdürülemeyebilir.
- Ruh sağlığı desteği gerektiğinde uygun profesyonellere yönlendirme yapılmalı; akran desteği güçlü bir kaynak olarak değerlendirilmelidir.

Aile ve Bakım Verenler

- Fiziksel engellilik aile içindeki rolleri, iş bölümünü ve ekonomik düzeni değiştirebilir.
- Bakım yükü Türkiye'de çoğunlukla kadınlar (anne, eş, kız çocuğu) tarafından üstlenilmektedir.
- Bakım verenlerde fiziksel yorgunluk, tükenmişlik, sosyal izolasyon ve gelir kaybı görülebilir.
- Aşırı koruyucu tutumlar, iyi niyetli olsa da kişinin özerkliğini ve becerilerini sınırlayabilir.
- Aileyle çalışmada hem engelli bireyin hem de bakım verenin ihtiyaçları ayrı ayrı değerlendirilmeli; mola (geçici bakım) olanakları araştırılmalıdır.

Eğitim Hakkı ve Fiziksel Engellilik

- Fiziksel engelli öğrencilerin önemli bir bölümü kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla genel eğitim okullarında öğrenim görmektedir.
- Okul binalarının, sınıfların, tuvaletlerin ve okul servislerinin erişilebilirliği eğitime katılımı doğrudan etkiler.
- Taşımalı eğitim uygulaması özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin okula ulaşımını destekler.
- Yükseköğretimde engelli öğrenci birimleri; sınav düzenlemeleri, kampüs erişilebilirliği ve barınma konularında destek sunar.
- Sosyal hizmet uzmanı öğrenci, aile ve okul arasında koordinasyon kurarak eğitimden kopmayı önlemeye çalışır.

İstihdam: Veriler ve Yasal Çerçeve

- Engelli nüfusun işgücüne katılım oranı %22,1 iken genel nüfusta bu oran %53,2'dir; engelli kadınlarda oran %12,5'e düşmektedir.
- 4857 sayılı İş Kanunu'na göre 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerleri %3, kamu işyerleri %4 oranında engelli çalıştırmakla yükümlüdür.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu kurumlarında %3 oranında engelli memur istihdamını öngörür; alım EKPSS ile yapılır.
- Kota sistemine karşın özel sektörde ve kamuda kota açığı sürmektedir.
- Kaynak: EYHGM İstatistik Bülteni (Ekim 2023). Bu oranlar değişmiş olabilir ama ulaşabildiğim en güncel yayın bu.

İstihdamdaki Engeller ve Destekli İstihdam

- Ulaşım güçlükleri, erişilemeyen işyerleri ve işyeri uyarlamalarının yapılmaması istihdamı sınırlar.
- İşverenlerin önyargıları ve “verimsizlik” varsayımları işe alım ve yükselmede ayrımcılığa yol açabilir.
- Bazı kişiler aylık kaybetme kaygısıyla düşük ücretli işlere başvurmaktan kaçınabilir.
- Destekli istihdam, iş koçluğu, mesleki rehabilitasyon ve işyeri uyarlaması istihdama katılımı artıran yaklaşımlardır.
- Sosyal hizmet uzmanı; kişi, İŞKUR ve işveren arasında köprü kurar, makul düzenleme taleplerinde savunuculuk yapar.

Sosyal Koruma: Nakdi Destekler

- 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık koşulunu sağlayan engelli bireylere engellilik oranına göre aylık bağlanır.
- 18 yaş altında engelli çocuğu olan muhtaç ailelere engelli yakını aylığı ödenir.
- 2828 sayılı Kanun kapsamında ağır engelli bireyin evde bakımını üstlenen yakına, gelir ölçütüne bağlı olarak evde bakım yardımı yapılır.
- Evde bakım yardımından 2023 Ekim itibarıyla yaklaşık 562 bin kişi yararlanmaktadır; yararlananların yaklaşık %17'si bedensel engel grubundadır.
- Nakdi destekler önemlidir; ancak tek başına bağımsız yaşamı ve toplumsal katılımı sağlamaz.

Bakım Hizmetleri: Kurum Merkezli mi, Toplum Temelli mi?

- Resmi ve özel bakım merkezleri yatılı ve gündüzlü bakım sunar; Umut Evleri ev tipi bir hizmet modelidir.
- Kurumsal bakım, bazı durumlarda gerekli olabilir; ancak tek seçenek olarak sunulmamalıdır.
- Bağımsız yaşam yaklaşımı; kişisel asistanlık, evde destek, erişilebilir konut ve ulaşımı öne çıkarır.
- Türkiye'de kişisel asistanlık gibi toplum temelli destek modelleri henüz sınırlı düzeydedir.
- Sosyal hizmet uzmanı, kişinin nerede ve nasıl yaşamak istediğini sorarak seçenekleri birlikte değerlendirir.

Diğer Hak ve Hizmetler

- Şehir içi toplu taşımada ücretsiz seyahat hakkı ve şehirlerarası ulaşımda indirimler.
- Gelir vergisinde engellilik indirimi ve bazı koşullarda araç alımında vergi avantajları.
- Ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalılara erken emeklilik olanağı.
- Belediyelerin engelli hizmet birimleri; ulaşım, ev uyarlaması ve sosyal etkinlik desteği sunabilir.
- Hakların koşulları sıklıkla değiştiğinden uzman güncel mevzuatı izlemeli ve kişiyi doğru kuruma yönlendirmelidir.

Kesişen Dezavantajlar

- Engelli kadınlar istihdam, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde daha fazla engelle karşılaşabilir.
- Kırsal bölgelerde yaşayanlar rehabilitasyon, yardımcı teknoloji ve ulaşım olanaklarına daha zor ulaşır.
- Yoksulluk ve engellilik birbirini besleyen bir döngü oluşturabilir: engellilik gelir kaybına, yoksulluk hizmete erişimsizliğe yol açar.
- Göçmen ve mülteci engelli bireyler dil, belge ve hizmet hakkı konularında ek güçlükler yaşayabilir.
- Değerlendirme, kişinin birden fazla kimliğini ve yaşam koşulunu birlikte ele almalıdır.

Fiziksel Engellilik ve Yaşlanma

- Yaş ilerledikçe hareketle ilgili zorluklar belirgin biçimde artmaktadır.
- 2019 Türkiye Sağlık Araştırması'na göre 75 yaş ve üzerindekilerin %44,7'si yardım veya araç olmadan yürüyememektedir.
- Engelli bireylerin yaşlanması ile yaşlılıkta ortaya çıkan engellilik farklı ihtiyaçlar doğurabilir.
- Yaşlı engelli bireyler, hem yaş hem de engellilik temelli ayrımcılıkla karşılaşabilir.
- Engellilik ve yaşlılık hizmetleri arasında koordinasyon, gerontolojik sosyal hizmet açısından önemli bir alandır.

Sosyal Hizmet Uygulamasının Temel İlkeleri

- Hak temelli yaklaşım: kişi yardımın pasif alıcısı değil, hak sahibidir.
- Güçlendirme ve güçlü yönler yaklaşımı: kişinin becerileri, kaynakları ve hedefleri müdahalenin merkezindedir.
- Kişi merkezli planlama: hedefler uzman veya kurum tarafından değil, kişiyle birlikte belirlenir.
- Kişi-çevre bakış açısı: sorun yalnızca bireyde değil, birey ile çevresi arasındaki ilişkide aranır.
- Özerkliğe saygı: kişinin kendi yaşamıyla ilgili kararlarına, riskli görünse bile, saygı gösterilir ve karar süreçleri desteklenir.

Kapsamlı Psikososyal Değerlendirme

- Kişisel öykü: engelliliğin başlangıcı, seyri, kişinin bu süreçle ilgili anlatısı ve hedefleri.
- Günlük yaşam: öz bakım, hareketlilik, ev içi işler ve yardımcı araç ihtiyacı.
- Çevre: konutun ve yakın çevrenin erişilebilirliği, ulaşım olanakları.
- Sosyal ve ekonomik durum: aile ilişkileri, bakım düzeni, gelir, sosyal güvence, eğitim ve çalışma durumu.
- Hizmet ve haklar: mevcut rapor, yararlanılan hizmetler, erişilemeyen haklar ve bunların nedenleri.
- Ruhsal durum: duygudurum, baş etme biçimleri, sosyal destek ve risk etkenleri.

Mikro Düzey Müdahale

- Bireysel danışmanlık: kayıp, uyum ve yeni yaşam hedefleri üzerine çalışma.
- Bilgilendirme: haklar, hizmetler ve başvuru süreçleri hakkında erişilebilir bilgi sunma.
- Vaka yönetimi: sağlık, rehabilitasyon, eğitim, istihdam ve sosyal yardım hizmetlerinin eşgüdümü.
- Kaynak bağlantısı: yardımcı teknoloji, ev uyarlaması ve ulaşım desteklerine erişim.
- Bireysel savunuculuk: hak ihlali veya hizmet reddi durumunda kişiyle birlikte başvuru yollarını kullanma.

Mezzo Düzey Müdahale

- Aile danışmanlığı: rol değişimleri, bakım düzeni ve aile içi iletişim üzerine çalışma.
- Grup çalışmaları: benzer deneyimleri paylaşan bireyler ve bakım verenler için destek ve psikoeğitim grupları.
- Akran desteği: aynı deneyimi yaşamış ve uyum sağlamış kişilerle bağlantı kurma.
- Kurumlarla çalışma: okul, işyeri, hastane ve belediyelerde erişilebilirlik ve makul düzenleme için iş birliği.
- Topluluk kaynaklarını harekete geçirme: muhtarlık, dernekler, gönüllü ağlar.

Makro Düzey Müdahale

- Erişilebilirlik ihlallerinin belgelenmesi ve ilgili denetim mekanizmalarına bildirilmesi.
- Engelli örgütleriyle iş birliği; “Bizim için, bizsiz hiçbir şey” ilkesine dayalı politika savunuculuğu.
- Kişisel asistanlık ve toplum temelli destek hizmetlerinin geliştirilmesi için savunuculuk.
- Yerel yönetimlerin hizmet planlamasına katkı: ulaşım, kaldırım, park ve kamusal alan düzenlemeleri.
- Araştırma ve veri üretimi: hizmet açıklarını görünür kılan çalışmalar.

Multidisipliner Ekip ve Rehabilitasyon

- Rehabilitasyon; fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi, fizyoterapist, ergoterapist, ortez-protez teknisyeni, hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanının ortak çalışmasını gerektirir.
- Fizyoterapi hareket ve güce, ergoterapi ise günlük yaşam etkinliklerine ve çevre uyarlamasına odaklanır.
- Sosyal hizmet uzmanı ekipte kişinin sosyal çevresini, kaynaklarını ve topluma dönüş koşullarını temsil eder.
- Ekip kararlarında kişinin ve ailenin sesi doğrudan duyulmalıdır.
- Tıbbi rehabilitasyon tamamlansa bile sosyal ve mesleki rehabilitasyon süreci devam eder.

Hastanede Sosyal Hizmet: Akut Dönemden Taburculuğa

- Akut dönemde kişi ve aileye kriz müdahalesi, bilgilendirme ve duygusal destek sağlanır.
- Taburculuk planlaması erken başlamalıdır: ev erişilebilir mi, bakım kim tarafından ve nasıl sağlanacak?
- Rapor, yardımcı araç, ilaç ve sarf malzemesi gibi ihtiyaçlar taburculuk öncesinde belirlenmelidir.
- Rehabilitasyon merkezi, evde sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet kuruluşlarıyla bağlantı kurulur.
- Taburculuk sonrası izleme; yeniden yatışları ve sosyal izolasyonu önlemede önemlidir.

Etik Konular ve Dil Kullanımı

- “Sakat”, “özürlü”, “tekerlekli sandalyeye mahkûm” gibi ifadeler yerine kişiyi öne alan ifadeler tercih edilmelidir: “tekerlekli sandalye kullanan kişi”.
- Engelli bireyi “kahraman” ya da “acınacak kişi” olarak sunan anlatılardan kaçınılmalıdır.
- İletişim doğrudan kişiyle kurulmalı; refakatçi üzerinden konuşulmamalıdır.
- Yardımcı araçlar kişinin bedeninin bir uzantısı gibidir; izinsiz dokunulmamalı ve yer değiştirilmemelidir.
- Gizlilik, aydınlatılmış onam ve kişinin kendi kararlarını verme hakkı her aşamada korunmalıdır.

Vaka Çalışması: Mert

- Mert 24 yaşında, inşaat işçisi; altı ay önce geçirdiği motosiklet kazası sonucu parapleji gelişmiş ve tekerlekli sandalye kullanıyor.
- Bir ilçede, asansörsüz bir binanın üçüncü katında anne ve babasıyla yaşıyor; sigortasız çalıştığı için düzenli geliri yok.
- Nişanlısıyla ilişkisi belirsizleşmiş; arkadaşlarıyla görüşmeyi bırakmış, “artık hiçbir işe yaramam” diyor.
- Annesi tüm bakımı üstlenmiş; babası Mert’in kurumda kalmasının daha iyi olacağını düşünüyor.
- Mert, hastaneden taburcu edilmeyi bekliyor ve sosyal hizmet birimine yönlendirilmiş.

Vaka Tartışma Soruları

- ICF çerçevesine göre Mert’in katılımını sınırlayan çevresel ve kişisel etkenler nelerdir?
- Mert’in hangi haklara ve hizmetlere erişimi değerlendirilmelidir?
- Mikro, mezzo ve makro düzeyde hangi müdahaleler planlanabilir?
- Babanın kurum bakımı önerisi ile Mert’in tercihleri arasında nasıl bir yol izlenmelidir?
- Mert’in güçlü yönleri ve kaynakları nelerdir; müdahale planına nasıl dahil edilebilir?

Değerlendirme

- Fiziksel engellilik yalnızca bir beden yetersizliği değil, birey ile çevre arasındaki etkileşimin sonucudur.
- Aynı tanıya sahip kişilerin yaşamları; erişilebilirlik, gelir, aile desteği ve hizmetlere erişime göre büyük farklılıklar gösterir.
- Sosyal hizmet uzmanı, bireyi uyum sağlamaya zorlamak yerine çevreyi ve hizmetleri dönüştürmeyi hedefler.
- Temel mesaj: Fiziksel engellilikte sosyal hizmet; özerkliği, bağımsız yaşamı ve topluma tam katılımı güçlendiren bir hak savunuculuğudur.

Kaynaklar

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2023). Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni (Ekim 2023).
- Birleşmiş Milletler. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
- Dünya Sağlık Örgütü. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun; 2022 sayılı Kanun; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu; 4857 sayılı İş Kanunu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (güncel metinleriyle).
- Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (2019); Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (2019).

Kaynaklar

- EYHGM İstatistik Bülteni (Ekim 2023): https://www.aile.gov.tr/media/151724/eyhgm_istatistik_bulteni_ekim_23.pdf
- BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
- 5378 sayılı Kanun — Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: https://www.aile.gov.tr/eyhgm/mevzuat/ulusal-mevzuat/kanunlar/engelliler-hakkinda-kanun/
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası — Anayasa Mahkemesi: https://anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/